SERVICIO DE SALUD SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
SERVICIO SERVEI	NEUMOLOGIA
UNIDAD UNITAT	
NÚM.DE EPISODIO NÚM.D'EPISODI	
FECHA DE INGRESO DATA D'INGRÉS	06/01/2022
FECHA DE ALTA DATA D'ALTA	14/01/2022

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT

PRIMER APELLIDO PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO SEGON COGNOM			
NOMBRE NOM			
CIP DE LA CA CIP DE LA CA		NÚMERO Hª CLÍNICA NÚMERO Hª CLÍNICA	
CIP EUROPEO CIP EUROPEU		CÓDIGO SNS CODI SNS	
SEXO SEXE	Mujer	FECHA DE NACIMIENTO DATA DE NAIXIMENT	
DIRECCIÓN DIRECCIÓ			

Informe de Alta de Hospitalización / Informe d'Alta d'Hospitalització

Motivo de ingreso / Motiu d'ingrés

Mujer de 83 años de edad que ingresa por ENFERMEDAD COMUN procedente de Hospital General de Castelló - URG. GENERALES

Antecedentes / Antecedents

RAM: niega. Antecedentes Respiratorios: -Ex-fumadora desde hace mas de 40 años de 4 cig/dia. -Tras viaje prolongado en coche a Alemania, TVP + TEP bilateral en Francia en 2016, en tratamiento una temporada con Xarelto. TBC en la infancia (TAC del 2017 hallazgos compatibles con cambios post TBC). -Portadora de VMNI por SAOS (BiPAP puesta en Navarra). Antecedentes personales: - Dislipemia. - Ictus vertebrobasilar en sept 2021. - Deterioro cognitivo desde ingreso por ictus vertebrobasilar en estudio por Neurología. - Elevación hemidiafragma derecho. - Insuficiencia tricuspídea moderada. Tratamiento habitual: -ADIRO 100MG -MELITRACENO CLORHIDRATO / FLUPENTIXOL DICLORHIDRATO GRAGEAS 10 MG / 0,5 MG. -DONEPEZILO COMPRIMIDOS 5 MG. -BROMURO DE TIOTROPIO CAPSULAS + DISPOSITIVO 18 MCG. -URIDINA TRIFOSFATO CAPSULAS 1,33 MG. -PANTOPRAZOL 20 MG. -THICK AND EASY SABOR NEUTRO. Social: vive con el marido. Independiente para ABVD. Barthel 100. Rankin 0 Refiere 2 vacunas para SARS-2 aunque no constan en abucasis. Marido Pierre tlf 667493227

Enfermedad o proceso actual / Malaltia o procés actual

Paciente de 83 años traida en SVB a SUH por saturación baja. La paciente refiere aumento brusco de su disnea habitual desde hace una semana. No sintomatología infecciosa salvo congestión nasal. No fiebre.
No edemas de MMII, no disminución de la diuresis. No otra sintomatología. No refiere mayor sedentarismo del habitual en las últimas semanas.

Exploración física / Exploració física

En Urgencias:
06-01-2022 11:26 - Tª: 35.6 ºC (Timpánica); FC: 97 lat/min (Rítmica); Sat. O2: 70 % (Sin Oxígeno)
Auscultación cardíaca: Tonos cardiacos regulares, sin soplos audibles.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, disminución de mv en base pulmonar derecha. Taquipneica en reposo sin oxigenoterapia.
Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Murphy negativo, Blumberg negativo. No palpo masas ni megalias. Puño-percusión renal bilateral no dolorosa. Peristaltismo conservado.
MMII: sin edemas.

En sala de Neumología:
Paciente con buen estado general. Eupneica en reposo, refiere disnea con los mínimos esfuerzos.
En reposo no tiene trabajo respiratorio.
SatO2 con FMK 4 lpm 97%, reducimos a 2.5 lpm (interesan saturaciones en torno a 94%).
AP: mv disminuido en base dcha (elevación hemidiafragma).
Abdomen: blando, depresible, sin masas ni megalalias aparentes.
MMII: sin edemas. No asimetrías. Hommans negativo bilateral. No aumento de temperatura.

Exploraciones complementarias / Exploracions complementaries

CG ritmo sinusal, eje +60º, PR 0'12s, QRS estrecho, BRD. GASOMETRÍA ARTERIAL (aa) pH: 7.46 pO2: 45 satO2: 74.1 CO2: 24 HCO3: 20.4 AG: 15 HEMOSTASIA T. PROTROMBINA 11,7 seg (9,0 - 13,0) INDICE DE QUICK 97,0 % (70,0 - 120,0) INR 1,02 (0,80 - 1,20) TP RATIO 1,02 (0,80 - 1,20) TTPA RATIO 1,01 (0,80 - 1,25) T.TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIV 31,7 seg (25,1 - 38) FIBRINOGENO * 777,00 mg/dL (200,00 - 400,00) DIMEROS D * 3.831,00 ng/mL (0 - 500) HEMOGRAMA HEMATIES 5,09 x 10^6/µL (4,20 - 6,10) HEMOGLOBINA 15,2 g/dL (12,0 - 18,0) HEMATOCRITO 47,3 % (37,0 - 52,0) VOLUMEN

SERVICIO DE SALUD SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
SERVICIO SERVEI	NEUMOLOGIA
UNIDAD UNITAT	
NÚM.DE EPISODIO NÚM.D'EPISODI	
FECHA DE INGRESO DATA D'INGRÉS	06/01/2022
FECHA DE ALTA DATA D'ALTA	14/01/2022

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT

PRIMER APELLIDO PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO SEGON COGNOM			
NOMBRE NOM			
CIP DE LA CA CIP DE LA CA		NÚMERO Hª CLÍNICA NÚMERO Hª CLÍNICA	
CIP EUROPEO CIP EUROPEU		CÓDIGO SNS CODI SNS	
SEXO SEXE	Mujer	FECHA DE NACIMIENTO DATA DE NAIXIMENT	
DIRECCIÓN DIRECCIÓ			

Informe de Alta de Hospitalización / Informe d'Alta d'Hospitalització

CORPUSCULAR MEDIO 92,9 fL (80 - 94) HBG CORPUSCULAR MEDIA 29,8 pg (27,0 - 31,0) CONC. HBG CORPUSCULAR MEDIA * 32,0 g/dL (33,0 - 37,0) RDW-CV 13,6 % (11,6 - 14,5) LEUCOCITOS * 14,30 x 10^3/µL (4,80 - 10,80) NEUTROFILOS * 8,90 x 10^3/µL (1,90 - 8,00) LINFOCITOS 3,40 x 10^3/µL (0,90 - 5,20) MONOCITOS * 1,80 x 10^3/µL (0,16 - 1,00) EOSINOFILOS 0,10 x 10^3/µL (0,00 - 0,80) BASOFILOS 0,10 x 10^3/µL (0,00 - 0,20) NEUTROFILOS % 62,7 % (40,0 - 70,0) LINFOCITOS % 23,7 % (19,0 - 48,0) MONOCITOS % * 12,3 % (3,4 - 9,0) EOSINOFILOS % 0,6 % (0,0 - 7,0) BASOFILOS % 0,7 % (0,0 - 1,5) PLAQUETAS 305 x 10^3/µL (130 - 400) 1ª BIOQUÍMICA PROCALCITONINA 0,05 ng/mL (0.00-0.10) TROPONINA ULTRASENSIBLE * 76,68 ng/L (0,02 - 14,00) MIOGLOBINA 46 ng/mL (12 - 70) GLUCOSA * 264 mg/dL (70 - 110) UREA * 51 mg/dL (10.0 -- 50.0) CREATININA * 1,01 mg/dL (0,51 - 0,95) FILTRADO GLOM.ESTIMADO CKD-EPI * 51,52 ml/min/sup (60.00-200.0) SODIO 137 mmol/L (134-145) POTASIO 4,37 mmol/L (3.50-5.00) CLORO 102 mmol/L (95-105) BILIRRUBINA TOTAL 0,62 mg/dL (0.50-1.0) GPT * 47 UI/L (10-37) GOT * 55 UI/L (10-38) GGT * 219 UI/L (7.0-50) FOSFATASA ALCALINA * 175 UI/L (40-145) CPK * 48 UI/L (50-195.0) LDH * 274 UI/L (0 - 248) PROTEINA C REACTIVA * 66,44 mg/L (1.00-10.0) FERRITINA 222 ng/mL (20 - 300) NT- PROBNP * 11.924 pg/mL (20 - 125) 2ª BIOQUÍMICA TROPONINA ULTRASENSIBLE * 65,34 ng/L RX TÓRAX Estudio portátil, poco inspirado. Elevación diafragmática derecha. Elongación de troncos supraaórticos. No hay evidencia de consolidaciones del espacio aéreo. TAC VASCULAR ARTERIAS PULMONARES Defectos de repleción bilaterales compatibles con TEP agudo en arterias: - apical y segmentaria anterior del LSD, lobar media y lobar inferior derecha - segmentaria anterior del LSI, basal anteromedial, basal lateral y basal posterior del LII No se observan defectos de repleción en las arterias pulmonares principales ni en el cono de la pulmonar. Áreas parcheadas en vidrio deslustrado, predominantemente de distribución peribroncovascular, que podrían estar en relación con el TEP (trastornos de la ventilación-perfusión), sin observar consolidaciones alveolares. Aplamiento y rectificación del tabique interventricular, así como reflujo de contraste a vena cava inferior como signos de sobrecarga de cavidades cardíacas derechas. Atelectasia-líquido en cisura menor derecha. No derrame pleural. Bocio endotorácico izquierdo. Elevación de hemidiafragma derecho. Atrofia renal derecha. PCR Nuevo Coronavirus 2019-nCoV NEGATIVO Detección antígeno SARS-CoV-2 NEGATIVO ECOCARDIOGRAFIA: Ventrículo izquierdo de dimensiones normales y función sistólica conservada. FE estimada >65%. Ventrículo derecho de dimensiones levemente aumentadas con función sistólica conservada (TAPSE 19 mm) pero con signos indirectos de sobrecarga (movimiento anormal de septo en telediastole (septo en D)). No es posible estimar PAPs por ausencia de señal de IT. TAP acortado (TAP 90 ms). No se aprecian alteraciones de contractilidad segmentaria. Válvulas de estructura normal. Doppler valvular sin alteraciones significativas. Ausencia de derrame pericárdico. Nota: signos indirectos de sobrecarga de cavidades derechas en el contexto de TEP. ECODOPPLER MMII: MID A nivel inguinal sistema venoso profundo y superficial compresible y permeable, ondas fásicas con la respiración y a la compresión distal. En hueco popliteo sistema venoso profundo y superficial compresión y permeable, ondas de flujo anterógrado a la compresión gemelar. En zona maleolar venas tibiales posteriores compresibles, ondas fásicas a la compresión plantar. MII A nivel inguinal sistema venoso profundo y superficial compresible y permeable, ondas fásicas con la respiración y a la compresión distal. En hueco popliteo sistema venoso profundo y superficial compresión y permeable, ondas de flujo anterógrado a la compresión gemelar. En zona maleolar venas tibiales posteriores compresibles, ondas fásicas a la compresión plantar. conclusiones: no signos de trombosis venosa profunda o superficial en los territorios explorados. ANALÍTICA AL ALTA: PH SANGUINEO * 7,510 (7.350-7.450) PCO2 SANGUINEO 42,0 mmHg (35.0-45.0) PO2 SANGUINEO * 53,0 mmHg (69.0-115.0) CO2 total 34,8 mmol/L EXCESO BASE ACTUAL * 9,5 mmol/L (-2.4-2.3) EXCESO BASE STANDARD * 10,5 mmol/L (-2.5-2.5) BICARBONATO ACTUAL * 33,5 mmol/L (22.0-26.0) BICARBONATO STD * 31,8 mmol/L (22.0-28.0) SATURACION OXIGENO * 86,9 % (95.0-99.0) OXIHEMOGLOBINA * 84,60 % (94.00-97.00) CARBOXIHEMOGLOBINA 2,20 % (1.50-5.00)

SERVICIO DE SALUD SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
SERVICIO SERVEI	NEUMOLOGIA
UNIDAD UNITAT	
NÚM.DE EPISODIO NÚM.D'EPISODI	
FECHA DE INGRESO DATA D'INGRÉS	06/01/2022
FECHA DE ALTA DATA D'ALTA	14/01/2022

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT

PRIMER APELLIDO PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO SEGON COGNOM			
NOMBRE NOM			
CIP DE LA CA CIP DE LA CA		NÚMERO Hª CLÍNICA NÚMERO Hª CLÍNICA	
CIP EUROPEO CIP EUROPEU		CÓDIGO SNS CODI SNS	
SEXO SEXE	Mujer	FECHA DE NACIMIENTO DATA DE NAIXIMENT	
DIRECCIÓN DIRECCIÓ			

Informe de Alta de Hospitalización / Informe d'Alta d'Hospitalització

METAHEMOGLOBINA 0,60 % (0.40-1.50) HEMOGLOBINA REDUCIDA * 12,70 % (0.10-5.00) HEMOSTASIA BÁSICA T. PROTROMBINA 11,5 seg (9,0 - 13,0) INDICE DE QUICK 100,0 % (70,0 - 120,0) INR 1,00 (0,80 - 1,20) TP RATIO 1,00 (0,80 - 1,20) TTPA RATIO * 1,30 (0,80 - 1,25) T.TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIV * 40,8 seg (25,1 - 38) FIBRINOGENO * 807,00 mg/dL (200,00 - 400,00) DIMEROS D * 1.631,00 ng/mL (0 - 500) HEMOGRAMA HEMATIES 4,84 x 10^6/µL (4,20 - 6,10) HEMOGLOBINA 14,5 g/dL (12,0 - 18,0) HEMATOCRITO 43,5 % (37,0 - 52,0) VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 90,0 fL (80 - 94) HBG CORPUSCULAR MEDIA 30,0 pg (27,0 - 31,0) CONC. HBG CORPUSCULAR MEDIA 33,4 g/dL (33,0 - 37,0) RDW-CV 12,7 % (11,6 - 14,5) LEUCOCITOS 8,30 x 10^3/µL (4,80 - 10,80) NEUTROFILOS 4,90 x 10^3/µL (1,90 - 8,00) LINFOCITOS 2,00 x 10^3/µL (0,90 - 5,20) MONOCITOS 1,00 x 10^3/µL (0,16 - 1,00) EOSINOFILOS 0,30 x 10^3/µL (0,00 - 0,80) BASOFILOS 0,10 x 10^3/µL (0,00 - 0,20) NEUTROFILOS % 58,4 % (40,0 - 70,0) LINFOCITOS % 24,7 % (19,0 - 48,0) MONOCITOS % * 12,6 % (3,4 - 9,0) EOSINOFILOS % 3,5 % (0,0 - 7,0) BASOFILOS % 0,8 % (0,0 - 1,5) PLAQUETAS 347 x 10^3/µL (130 - 400) MPV 8,4 fL PDW * 17,1 fL (25,0 - 65,0) PCT 0,29 % BIOQUIMICA SUEROS ANALCLIN GLUCOSA * 120 mg/dL (70 - 110) UREA * 56 mg/dL (10.0 -- 50.0) CREATININA 0,62 mg/dL (0,51 - 0,95) FILTRADO GLOM.ESTIMADO CKD-EPI 83,56 ml/min/sup (60.00-200.0) SODIO 138 mmol/L (134-145) POTASIO 3,80 mmol/L (3.50-5.00) CLORO 96 mmol/L (95-105) BILIRRUBINA TOTAL * 0,40 mg/dL (0.50-1.0) GPT * 42 UI/L (10-37) GOT 36 UI/L (10-38) GGT * 301 UI/L (7.0-50) FOSFATASA ALCALINA * 261 UI/L (40-145) CPK * 15 UI/L (50-195.0) LDH 168 UI/L (0 - 248) PROTEINA C REACTIVA * 56,50 mg/L (1.00-10.0) FERRITINA 285 ng/mL (20 - 300) TROPONINA ULTRASENSIBLE * 20,40 ng/L (0,02 - 14,00) NT- PROBNP 114 pg/mL (20 - 125)

Evolución / Evolució

Durante el ingreso en planta se instaura tratamiento anticoagulante. El paciente presenta una mejoría clínica progresiva desapareciendo la disnea.
Durante su estancia en el hospital permanece afebril y estable hemodinámicamente en todo momento. Dada la mejoría clínica experimentada se decide alta hospitalaria.

Diagnóstico principal / Diagnòstic principal

TEP RIESGO INTERMEDIO ALTO

Diagnósticos secundarios / Diagnòstics secundaris

SEGUNDO EPISODIO TEP INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA CON HIPOXEMIA

Tratamiento al alta / Tractament a l'alta

- ENOXAPARINA 60mg 1 inyección sc cada 12 horas.
- Uso de OXÍGENO DOMICILIARIO 2 l/min 24 horas al día hasta valoración en consultas externas.

Mantener medicación habitual igual.

Recomendaciones / Recomanacions

Se le llamará para asignar cita de revisión en consultas externas de hematología y neumología.

Circunstancias al alta / Circumstàncies a l'alta

CONSULTAS EXTERNAS - C. EXT. NEUMOLOGIA

SERVICIO DE SALUD ***SERVEI DE SALUT***	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO ***DENOMINACIÓ DEL CENTRE***	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
SERVICIO ***SERVEI***	NEUMOLOGIA
UNIDAD ***UNITAT***	
NÚM.DE EPISODIO ***NÚM.D'EPISODI***	
FECHA DE INGRESO ***DATA D'INGRÉS***	06/01/2022
FECHA DE ALTA ***DATA D'ALTA***	14/01/2022

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT

PRIMER APELLIDO ***PRIMER COGNOM***			
SEGUNDO APELLIDO ***SEGON COGNOM***			
NOMBRE ***NOM***			
CIP DE LA CA ***CIP DE LA CA***		***NÚMERO Hª CLÍNICA*** ***NÚMERO Hª CLÍNICA***	
CIP EUROPEO ***CIP EUROPEU***		***CÓDIGO SNS*** ***CODI SNS***	
SEXO ***SEXE***	Mujer	***FECHA DE NACIMIENTO*** ***DATA DE NAIXIMENT***	
DIRECCIÓN ***DIRECCIÓ***			

Informe de Alta de Hospitalización / Informe d'Alta d'Hospitalització

Responsable:

Sección / Secció: NEUMOLOGIA

Fecha / Data:

Fecha creación / Data creació: 14/01/2022